

Come si trasforma il vissuto del paziente in un dato clinico solido?

Sette tavole sulle scale validate e i parametri dei nostri studi ospedalieri. Sfoglia →



Dott. Matteo Era
Medico Chirurgo · Head of Clinical R&D · Lemons in the Room

Lemons in the room

IL METODO VR-CORE IN CORSIA

Misurare con rigore ciò che il paziente vive, in meno di due minuti.

Nei nostri protocolli ospedalieri seguiamo il consenso internazionale **VR-CORE** (Birckhead et al., *JMIR* 2019), integrando scale validate e parametri oggettivi di reparto.

1 · SCALE PSICOMETRICHE (PROS)

Esperienza misurata

VAS, NRS 0-10, Wong-Baker FACES, Distress Thermometer, STAI-6 e GAD-7 validati in italiano.

2 · PARAMETRI DI SALA

Conferma fisiologica

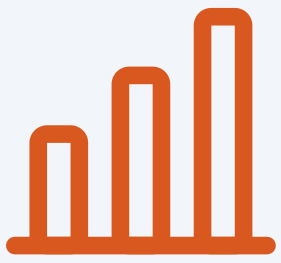
Frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione e consumo di farmaci sedativi o analgesici.

Birckhead B et al., JMIR Ment Health 2019;6(1):e11973 (VR-CORE)

Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

LIVELLO 1 · DOLORE E DISTRESS

Scale VAS, NRS (0–10), Wong-Baker FACES e Distress Thermometer



Strumenti gold-standard internazionali che permettono al paziente adulto o pediatrico di esprimere con precisione dolore e distress in meno di 30 secondi al letto.

SOGLIA DI RILEVANZA CLINICA (MCID)

Una riduzione **≥ 1,3 – 1,5 punti su scala 0-10** rappresenta una differenza clinicamente significativa per il paziente (criteri IMMPACT, Dworkin et al. 2008) e guida il calcolo campionario dei nostri RCT.

Dworkin RH et al., Pain 2008 · Hawker GA et al., Arthritis Care Res 2011

Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

Questionari strutturati ad alta affidabilità: STAI-6 e GAD-7



Accanto alle scale numeriche, i questionari multi-item colgono le dimensioni cognitive, emotive e somatiche dell’ansia con elevata coerenza interna (α di Cronbach 0,85–0,92).

COMPLEMENTARITÀ NEI PROTOCOLLI

Impieghiamo la **STAI-6** (Marteau & Bekker, 1992) nelle procedure interventistiche in singola seduta e il **GAD-7** (Spitzer et al., 2006) con il **Distress Thermometer** nei cicli terapeutici ripetuti come l’oncologia.

Marteau & Bekker, Br J Clin Psychol 1992 · Spitzer RL et al., Arch Intern Med 2006

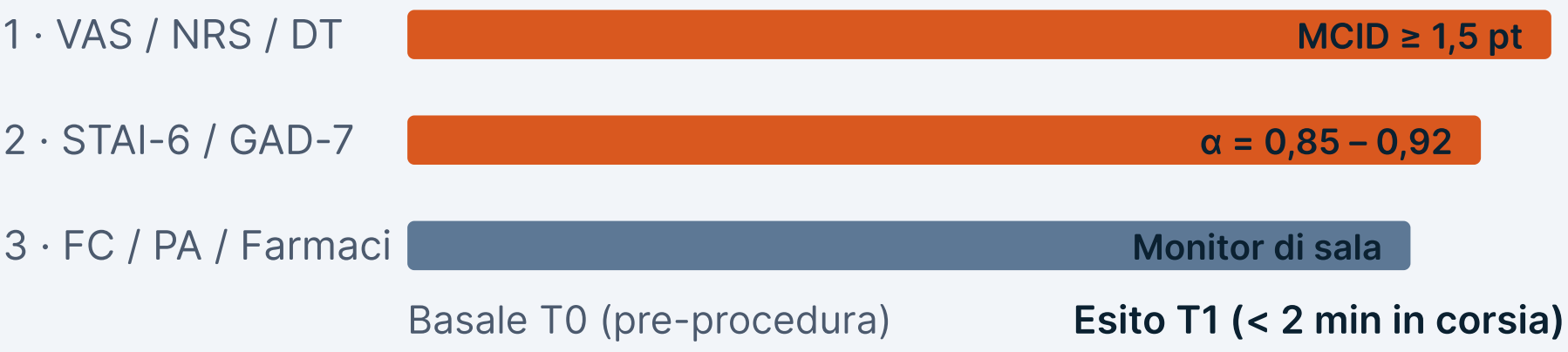
Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

CONVERGENZA MULTIMODALE

Quando scale validate e parametri vitali raccontano lo stesso risultato.

La solidità di uno studio clinico nasce dalla concordanza tra la riduzione del punteggio riferito dal paziente (PROs) e la stabilizzazione autonomica misurata sul monitor multiparametrico.

Convergenza dei 3 domini di misura validati (T0 pre → T1 post)



Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

3 REGOLE NEI NOSTRI PROTOCOLLI

Rigore statistico e zero attrito per il personale in turno.

1 Rilevazione pre-post in meno di 120 secondi

Scale brevi somministrate a T0 (basale) e T1 (post-procedura) senza rallentare l'équipe

2 Analisi ANCOVA aggiustata per il basale T0

Controlla la variabilità individuale di partenza e porta la potenza statistica oltre il 90%

3 Triangolazione con esiti clinici e organizzativi

Frequenza cardiaca, tempi di procedura, recupero post-sala e farmaci al bisogno

Linee guida CONSORT e VR-CORE · Protocolli Clinici Lemons in the Room

Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room

CONFRONTO TRA SPERIMENTATORI

Quali scale utilizzate nei vostri studi clinici in reparto?



Misurare con strumenti validati valorizza il lavoro di medici, infermieri e psicologi e trasforma l’umanizzazione delle cure in evidenza scientifica condivisa.

DIALOGO CON I REPARTI

Nelle vostre sperimentazioni su dolore e ansia in ospedale, quale combinazione di scale e parametri vitali vi ha dato il riscontro migliore?

Dott. Matteo Era
Head of Clinical Research and Development · Lemons in the Room